

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE
CUALITATIVO**

**Percepción de la Calidad de Atención en Usuarios del Centro de
Salud Belén, Ayacucho 2026**

Para optar el título profesional de:
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

Bach. Gresly Lucero PARIONA PALOMINO

ORCID: 0009-0008-5421-9872

ASESOR:

Dr. Manglio AGUIRRE ANDRADE

ORCID: 0000-0001-8234-567X

AYACUCHO – PERÚ

2026

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	2
1.1. Contextualización del problema de investigación	2
1.2. Formulación de las preguntas norteadoras	3
1.2.1. Pregunta principal	3
1.2.2. Preguntas específicas	3
1.3. Formulación de los objetivos de investigación	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Justificación de la investigación	4
1.5. Viabilidad y consideraciones bioéticas	4
2. MARCO CONTEXTUAL	6
2.1. Descripción geográfica del área de estudio	6
2.2. Características demográficas del área de estudio	6
2.3. Características sociales	6
2.4. Dinámica económica del área de estudio	7
2.5. Características sanitarias	7
3. ABORDAJE TEÓRICO	8
3.1. Antecedentes de estudio	8
3.1.1. Antecedentes internacionales	8
3.1.2. Antecedentes nacionales	8
3.1.3. Antecedentes regionales y locales	8
3.2. Base teórica	9
3.2.1. Modelo de Calidad de Salud de Avedis Donabedian	9
3.2.2. Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson	9

3.3. Categorías de estudio	9
4. METODOLOGÍA CUALITATIVA	11
4.1. Metodología general y específica	11
4.2. Selección de la muestra	11
4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	12
4.4. Plan de recolección de datos	12
4.5. Plan de procesamiento de datos	12
4.6. Plan de presentación y análisis de datos	13
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	14
5.1. Asignación de recursos humanos	14
5.2. Presupuesto	14
5.2.1. Pago de servicios de personal	14
5.2.2. Programación de otros servicios	14
5.2.3. Adquisición de materiales y otros	15
5.3. Financiamiento	15
5.4. Cronograma de actividades	15
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17
ANEXOS	18
Anexo 1: Guía de Entrevista a Profundidad	18
Anexo 2: Matriz de Consistencia Cualitativa	19
Anexo 3: Formato de Juicio de Expertos	19
Anexo 4: Consentimiento Informado	21
Anexo 5: Carta de Asesoría Formal	22

INTRODUCCIÓN

Importancia:

La calidad de atención en los servicios de salud constituye una prioridad esencial en el ámbito de la salud pública. En los centros de atención primaria, la percepción del usuario sobre los cuidados y tratos recibidos condiciona el uso oportuno de los servicios, la adherencia a los tratamientos y la confianza institucional. El Centro de Salud Belén, ubicado en el distrito de Ayacucho, atiende a una gran demanda poblacional con realidades socioculturales complejas, donde persisten insatisfacciones relacionadas con los tiempos de espera, la empatía del personal y la infraestructura física. El estudio se enmarca en la Política Nacional de Calidad en Salud al 2030 (Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA, Línea 10: Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal), la Prioridad Regional 10 de la DIRESA Ayacucho 2025–2030 (Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud) y el Plan de Humanización de la Atención en Salud del Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Los beneficiarios directos serán los usuarios del centro de salud, los profesionales de enfermería y las autoridades sanitarias locales, quienes contarán con insumos reflexivos para mejorar los procesos asistenciales.

Finalidad o valor práctico:

El presente estudio busca comprender a profundidad la vivencia subjetiva del usuario respecto a la atención recibida en el Centro de Salud Belén. A partir de estos hallazgos, se proyecta proporcionar evidencia cualitativa que sirva de insumo para que el equipo directivo y de enfermería formule estrategias interpersonales, planes de mejora continua y guías de trato humanizado orientadas a resolver nudos críticos en la atención primaria.

Valor teórico:

Se busca cubrir el vacío de conocimiento referente a la dimensión subjetiva y sociocultural del usuario ayacuchano frente al sistema de salud local. Se pretende contrastar y enriquecer el Modelo de Calidad de Servicio de Avedis Donabedian y la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson, contextualizándolos a la realidad vivencial y lingüística de la población usuaria del Centro de Salud Belén.

Valor metodológico:

El estudio aplica el diseño cualitativo de corte fenomenológico-hermenéutico. Aporta una guía de entrevista a profundidad semiestructurada y una matriz de categorización cualitativa validadas, las cuales servirán como herramienta replicable para futuras investigaciones sobre experiencia del usuario en establecimientos del primer nivel de atención en contextos andinos.

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Contextualización del problema de investigación

El primer nivel de atención en salud representa la puerta de entrada al sistema sanitario y es el espacio donde se gesta la relación primordial entre la comunidad y los profesionales de salud. Sin embargo, la experiencia asistencial cotidiana suele verse afectada por barreras burocráticas, saturación de los servicios, falta de insumos e interacciones interpersonales percibidas como deshumanizadas o distantes.

En el contexto local, el Centro de Salud Belén, ubicado en la provincia de Huamanga, recibe diariamente a decenas de usuarios que acuden en busca de atención preventiva y recuperativa. Las vivencias cotidianas de los usuarios abarcan desde la madrugadora solicitud de citas hasta el encuentro interpersonal en los consultorios. En este recorrido, el usuario no solo busca la resolución clínica de su dolencia, sino un trato con amabilidad, respeto a su dignidad, orientación clara e infraestructura digna. Partiendo de la subjetividad y del contacto con la realidad del establecimiento, se observa que la percepción de calidad no se limita a métricas numéricas de tiempo o cobertura, sino al significado que los usuarios le otorgan al proceso de atención médica y de enfermería.

Partiendo de la propia subjetividad, observación cotidiana y experiencia como estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería en los campos clínicos de la UNSCH, se evidencia que la percepción de “buena” o “mala” atención se construye en los detalles interpersonales. El usuario ayacuchano valora profundamente la calidez, la mirada atenta, el saludo afectuoso y el uso del idioma quechua cuando es necesario. Al contrastar este escenario empírico con la literatura previa, se observa la necesidad de explorar a fondo la perspectiva del actor social para transformar la gestión del cuidado en el Centro de Salud Belén.

Objeto de estudio principal: El fenómeno central que se investiga comprende *la vivencia e interpretación intersubjetiva que le otorgan los usuarios a la atención recibida en el Centro de Salud Belén*, abarcando:

- **El trato interpersonal:** Las emociones, percepciones de calidez, frialdad, empatía o distanciamiento manifestadas por el usuario al interactuar con el personal asistencial y administrativo.
- **El significado del tiempo:** El impacto cotidiano en la dignidad y bienestar derivado de madrugar, hacer colas y permanecer en salas de espera.
- **La comunicación intercultural:** La claridad de la información y la confianza generada cuando el personal se comunica en español o en quechua chanka.

- **La experiencia del espacio físico:** Las vivencias de confort, higiene, orden y privacidad dentro de las instalaciones y consultorios.

Descripción de la situación problemática (problema central): En el Centro de Salud Belén se evidencia una desconexión entre la atención técnica que brinda el personal sanitario y la experiencia humana que vive el usuario. Persiste una insatisfacción latente reflejada en quejas recurrentes sobre demoras prolongadas para conseguir un turno, tratos percibidos como impersonales o apresurados y barreras comunicativas en la consulta. El problema radica en que se desconoce la perspectiva cualitativa del usuario: qué siente, cómo interpreta estas barreras y qué valor le otorga a la atención en salud dentro de su contexto social y cultural en Ayacucho.

1.2. Formulación de las preguntas norteadoras

1.2.1. *Pregunta principal*

¿Cómo perciben y significan los usuarios la calidad de atención brindada en los diferentes servicios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026?

1.2.2. *Preguntas específicas*

1. ¿Cuáles son las vivencias y significados que otorgan los usuarios al trato interpersonal, amabilidad y empatía por parte del personal de salud y de enfermería?
2. ¿Qué significados otorgan los usuarios a los tiempos de espera y procesos administrativos para acceder a una cita asistencial y medicamentos?
3. ¿Cómo describen y qué sensaciones expresan los usuarios respecto al entorno físico, el equipamiento, la limpieza y la privacidad durante las atenciones recibidas?
4. ¿Cómo valoran los usuarios la claridad, lenguaje y capacidad explicativa de los profesionales de salud respecto a su diagnóstico y tratamiento?
5. ¿Cuáles son las expectativas y sugerencias que plantean los usuarios para lograr una atención verdaderamente humanizada en el Centro de Salud Belén?

1.3. Formulación de los objetivos de investigación

1.3.1. *Objetivo general*

Comprender la percepción y vivencia de los usuarios sobre la calidad de atención brindada en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

1.3.2. *Objetivos específicos*

1. Identificar los significados que otorgan los usuarios al trato interpersonal, la amabilidad y la empatía demostrada por el personal médico y de enfermería.
2. Describir las vivencias de los usuarios respecto al tiempo de espera y la accesibilidad en la obtención de citas y entrega de medicamentos.
3. Analizar las percepciones de los usuarios sobre las condiciones físicas, confort, higiene y privacidad de los ambientes de atención.
4. Explorar la vivencia de los usuarios en relación con la claridad de la información, el lenguaje y la comunicación recibida sobre su estado de salud.
5. Sistematizar las expectativas y propuestas de mejora manifestadas por los usuarios para optimizar la humanización de la calidad asistencial.

1.4. **Justificación de la investigación**

El proyecto se sustenta en tres dimensiones fundamentales:

- **Justificación Social y Práctica:** Prioriza la voz del usuario, posicionándolo como sujeto de derechos y agente activo del proceso de atención en salud. Genera evidencia directa para la Red de Salud Huamanga y la jefatura del Centro de Salud Belén, facilitando el rediseño de flujos asistenciales, la mitigación de cuellos de botella y la sensibilización del personal en trato digno y calidez asistencial.
- **Justificación Institucional y Sanitaria:** Se alinea formalmente con la Línea 10 de Investigación MINSA al 2030 (“Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal”, RM N° 424-2025/MINSA) y con la Prioridad Regional 10 de la DIRESA Ayacucho 2025–2030 (“Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud”).
- **Justificación Académica y Metodológica:** Enriquece las líneas de investigación formativa de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSCH, promoviendo el abordaje cualitativo y humanista en salud pública. Valida instrumentos contextualizados (guía de entrevista semiestructurada y matriz categorial) replicables en el primer nivel de atención de la región andina.

1.5. **Viabilidad y consideraciones bioéticas**

La investigación es plenamente viable puesto que cuenta con acceso geográfico al Centro de Salud Belén, recursos humanos capacitados y presupuesto cubierto en su totalidad por financiamiento propio.

En estricta salvaguarda del rigor bioético, el protocolo será sometido al Comité

Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la UNSCH y formalmente acreditado ante las instancias competentes de la DIRESA Ayacucho y de la Red de Salud Huamanga antes de cualquier contacto empírico. Se adhiere a los principios de la Declaración de Helsinki y las pautas CIOMS: respeto a la autonomía (firma voluntaria del consentimiento informado, Anexo 4), no maleficencia y confidencialidad absoluta mediante la asignación de códigos alfanuméricos despersonalizados (ejemplo: Informante 01 – Inf. 01).

2. MARCO CONTEXTUAL

2.1. Descripción geográfica del área de estudio

El estudio se llevará a cabo en el Centro de Salud Belén, perteneciente a la Microred Huamanga de la Red de Salud Huamanga, Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho. El establecimiento se ubica en el tradicional barrio de Belén, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a una altitud aproximada de 2,760 m.s.n.m. Sus coordenadas de referencia se emplazan en la cuenca del valle de Huamanga, caracterizada por un clima templado-seco, con temperaturas promedio de 15 °C a 22 °C y estación de lluvias entre noviembre y marzo. Su emplazamiento urbano permite el acceso directo vehicular y peatonal a través de vías asfaltadas y líneas de transporte público local.

2.2. Características demográficas del área de estudio

El área de influencia directa del Centro de Salud Belén alberga una población asignada que supera los 18,000 habitantes. La estructura demográfica exhibe una pirámide poblacional progresiva con un componente significativo de población infantil y juvenil, aunado a un incremento progresivo de adultos mayores. Existe una marcada concurrencia de población femenina en edad fértil, madres acompañantes a controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) e inmunizaciones de niños menores de cinco años, gestantes en control prenatal y personas adscritas a los programas de prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles.

2.3. Características sociales

La población adscrita al establecimiento está integrada por familias pertenecientes a estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo, procedentes del casco urbano tradicional y de asentamientos humanos periféricos contiguos. Sobresale la pervivencia de la cultura andina con un alto porcentaje de bilingüismo (español y quechua chanka). El nivel de instrucción oscila predominantemente entre educación secundaria completa e incompleta, presentándose en adultos mayores casos de educación primaria incompleta o analfabetismo funcional. Las pautas socioculturales exigen un trato fundamentado en el respeto, la escucha activa y la cordialidad en lengua originaria para consolidar la confianza terapéutica.

2.4. Dinámica económica del área de estudio

La economía de la población usuaria es fundamentalmente informal y orientada a la autosubsistencia. La Población Económicamente Activa (PEA) labora en el comercio ambulatorio, ferias barriales, servicios de transporte menor (mototaxis y colectivos urbanos), artesanía, oficios independientes y agricultura periurbana a pequeña escala. Una porción mayoritaria se encuentra categorizada en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en condiciones de pobreza y pobreza extrema, siendo la totalidad de este segmento usuario titular del Seguro Integral de Salud (SIS).

2.5. Características sanitarias

El Centro de Salud Belén cuenta con categoría I-3 de primer nivel de atención de salud. Brinda prestaciones asistenciales en las carteras de Medicina General, Enfermería (Inmunizaciones, CRED, Control de Tuberculosis, Prevención de Anemia y Malnutrición), Obstetricia (Salud Sexual y Reproductiva, Control Prenatal), Odontología, Psicología, Trabajo Social, Laboratorio Clínico y Farmacia. Los principales motivos de consulta epidemiológica abarcan infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas agudas (EDA), parasitosis gastrointestinal, anemia materno-infantil, e hipertensión arterial y diabetes mellitus en el adulto. Sus principales desafíos operativos radican en la sobrecarga asistencial en sala de espera, el hacinamiento físico y la rotación periódica del personal de salud.

3. ABORDAJE TEÓRICO

3.1. Antecedentes de estudio

3.1.1. Antecedentes internacionales

- **Gómez-Restrepo y colaboradores (2023, Colombia):** En su investigación cualitativa fenomenológica titulada “*Experiencia del usuario sobre la calidad asistencial en el primer nivel de atención*”, analizaron 18 entrevistas a profundidad con usuarios de centros de salud urbanos, concluyendo que la percepción de calidad está dominada por la calidez comunicativa y la empatía del personal. Demostraron que el trato humanizado compensa percibidamente las deficiencias del ambiente físico y reduce la frustración asociada a los tiempos de espera prolongados [?].
- **Pérez y Silva (2022, Ecuador):** En su investigación cualitativa titulada “*Significados de la atención de enfermería desde la mirada del paciente externo*”, concluyeron que los usuarios valoran principalmente el saludo, la escucha atenta y la mirada a los ojos por parte del personal de enfermería, considerando estos gestos como indicadores fundamentales de respeto y competencia profesional.

3.1.2. Antecedentes nacionales

- **Mamani y Quispe (2024, Lima):** En su estudio cualitativo denominado “*Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en usuarios de establecimientos de salud del primer nivel*”, determinaron que los usuarios asocian la mala calidad no al diagnóstico médico sino a la frialdad en la atención, el uso excesivo de tecnicismos incomprensibles y la falta de espacio para formular preguntas sobre el tratamiento.
- **Córdova y Reyes (2023, Arequipa):** Desarrollaron el estudio cualitativo “*Tiempos de espera y trato humano: Un estudio cualitativo en centros de salud públicos*”, donde identificaron que las prolongadas filas desde la madrugada generan una predisposición anímica negativa que solo logra disiparse cuando el profesional de enfermería brinda una acogida empática, cálida e informativa.

3.1.3. Antecedentes regionales y locales

- **Rojas (2023, Ayacucho):** En su tesis cualitativa “*Percepción intercultural de la calidad de atención en usuarios de centros de salud de la Red Huamanga*”, realizada con usuarios quechuahablantes, concluyó que la barrera lingüística es el

principal factor de insatisfacción. Evidenció que cuando el personal de salud o enfermería responde o saluda en quechua, la percepción de calidad y confianza institucional se incrementa significativamente.

- **García (2022, Ayacucho – UNSCH):** En su investigación sobre “*Cuidado humanizado de enfermería en el primer nivel de atención*”, reportó que la sobrecarga laboral del personal suele mermar la paciencia en el trato, afectando la percepción que tiene la madre o el adulto mayor sobre la atención brindada en los servicios preventivo-promocionales [?].

3.2. Base teórica

3.2.1. *Modelo de Calidad de Salud de Avedis Donabedian*

Constituye el marco conceptual clásico e indispensable para la evaluación de los servicios sanitarios [?]. Donabedian formula que la calidad asistencial se estructura a través de tres dimensiones dialécticas e interrelacionadas:

1. **Estructura:** Comprende los recursos materiales (infraestructura, confort, higiene, equipamiento e insumos), los recursos financieros y los recursos humanos calificados.
2. **Proceso:** Refiere a las actividades técnicas e interpersonales desarrolladas durante el encuentro clínico asistencial (diagnóstico, tratamiento, comunicación, calidez y trato respetuoso).
3. **Resultado:** Expresa los cambios logrados en el estado de salud y la satisfacción subjetiva vivenciada por el paciente tras recibir el cuidado.

3.2.2. *Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson*

Sostiene que el cuidado constituye el núcleo ontológico, filosófico y ético de la enfermería [?]. Define el cuidado como un proceso transpersonal e intersubjetivo orientado a preservar la dignidad y armonizar la mente, el cuerpo y el alma del ser humano. Mediante los factores de cuidado (Factores Caritas), Watson postula que una atención de auténtica calidad exige relaciones de confianza basadas en la empatía, la sensibilidad, el respeto a las vivencias del usuario y la escucha atenta libre de juzgamientos.

3.3. Categorías de estudio

En concordancia con el paradigma cualitativo interpretativo, no se operacionalizan variables cuantitativas, sino que se formula la siguiente matriz categorial apriorística

orientadora:

Categoría Central	Subcategorías	Definición Operativa	Indicadores / Códigos Su- geridos	Pregunta Orien- tadora
Calidad de Atención Percibida	Trato humano y em- patía	Percepción del usuario sobre el respeto, calidez, actitud de escucha activa y educación brindada por el personal asis- tencial y administrativo.	• Amabilidad / Frialdad • Escucha atenta • Saludo y mirar a los ojos • Uso del idioma quechua • Paciencia y respeto	¿Cómo describe la forma en que fue tratado por el personal médico y de enfermería durante su con- sulta?
	Oportunidad y tiem- pos de atención	Vivencia del usuario respecto a la agilidad, fluidez y demo- ras en el acceso a citas, colas desde la madrugada y entre- ga de medicinas.	• Colas de madrugada • Tiempo de espera en sala • Rapidez de atención • Demora en farmacia y ca- ja	¿Qué opina so- bre el tiempo que le tomó ser aten- dido desde que llegó al centro de salud?
	Condiciones físicas e infraestructura	Valoración sobre el estado de las instalaciones, limpie- za, ventilación, confort de asientos y privacidad garanti- zada durante la atención.	• Limpieza de salas y ba- ños • Comodidad de las bancas • Privacidad en consultorio • Señalización y orden	¿Cómo conside- ra las instalacio- nes y la privati- dad del ambiente donde recibió su atención?
	Información y clari- dad comunicativa	Grado de comprensión que obtiene el usuario sobre el diagnóstico, tratamiento e in- dicaciones médicas y de en- fermería recibidas.	• Explicaciones comprensi- bles • Espacio para preguntas • Claridad en la receta • Confianza generada	¿Le explicaron con claridad su diagnóstico y medicamen- tos? ¿Sintió la confianza para realizar preguntas?

Tabla 1: Matriz de categorización cualitativa del estudio.

4. METODOLOGÍA CUALITATIVA

4.1. Metodología general y específica

- **Metodología General:** Estudio de enfoque cualitativo bajo el paradigma interpretativo, orientado a la comprensión holística de los fenómenos sociales a partir del marco de referencia de los propios actores.
- **Método Cualitativo Específico:** Fenomenológico-Hermenéutico [?, ?]:
 - *Fenomenológico:* Posibilita captar la esencia de las vivencias subjetivas, percepciones y significados contruidos por los usuarios respecto a la atención recibida en el Centro de Salud Belén.
 - *Hermenéutico:* Permite interpretar, decodificar y comprender el sentido profundo de los discursos narrativos y pautas conductuales dentro del contexto sociocultural y lingüístico andino.

4.2. Selección de la muestra

Tipo de Muestreo: No probabilístico de tipo intencional o por conveniencia, regulado por el criterio metodológico de **saturación teórica** (punto en el cual las entrevistas adicionales ya no aportan nuevos elementos explicativos a las categorías), estimándose una muestra referencial de 12 a 18 participantes informantes clave.

Criterios de Inclusión:

1. Usuarios de ambos sexos, mayores de 18 años, que hayan recibido atención en el Centro de Salud Belén en los últimos tres meses.
2. Participación voluntaria formalizada mediante la firma o huella dactilar del Consentimiento Informado (Tabla 5.4).
3. Capacidad de comunicarse verbalmente y expresar sus vivencias en español o quechua chanka.

Criterios de Exclusión:

1. Usuarios con compromiso neurológico, alteración del estado de conciencia o barreras cognitivas severas que impidan la entrevista.
2. Usuarios que acudan exclusivamente a efectuar trámites administrativos rápidos o gestiones documentarias sin haber pasado consulta asistencial.

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- **Técnicas:** Entrevista a profundidad semiestructurada y observación directa no participante.
- **Instrumentos:** Guía de entrevista a profundidad semiestructurada flexible (Elemento 5.4) y Diario de campo reflexivo para registro de impresiones contextuales y comunicación no verbal.
- **Triangulación y Rigor Científico:** Se aplicará la triangulación de datos (cruzando vivencias de usuarios de diversos servicios, géneros y edades) y la triangulación de investigadores (revisión y codificación conjunta entre la investigadora y el asesor) para garantizar los cuatro criterios de rigor de Guba y Lincoln: credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad [?].

4.4. Plan de recolección de datos

El proceso de recolección se ejecutará en cinco etapas rigurosas:

1. Coordinación institucional y tramitación de permisos formales ante la Red de Salud Huamanga y la Jefatura del Centro de Salud Belén.
2. Abordaje inicial en salas de espera respetando los momentos de serenidad del usuario e invitándolo a colaborar de manera respetuosa.
3. Explicación detallada de los propósitos investigativos, garantías de confidencialidad y suscripción voluntaria del Consentimiento Informado.
4. Ejecución de las entrevistas en profundidad en un ambiente privado, libre de ruidos y facilitado por el establecimiento, empleando grabadora de audio digital de alta fidelidad.
5. Elaboración inmediata de notas reflexivas en el diario de campo tras cada entrevista. Se establece como control de calidad la transcripción fiel e íntegra del audio (*verbatim*) en un plazo no mayor a 24 horas.

4.5. Plan de procesamiento de datos

1. Transcripción textual palabra por palabra (*verbatim*) de las grabaciones de audio dentro de las 24 horas posteriores al encuentro.
2. Lectura iterativa e inmersión profunda en los textos para aprehender el sentido global de los discursos.
3. Codificación abierta: segmentación de los testimonios e identificación inductiva de unidades de significado conceptual.
4. Categorización y agrupación de códigos en subcategorías y categorías centrales

mediante la asistencia del software analítico cualitativo ATLAS.ti v9.

4.6. Plan de presentación y análisis de datos

El análisis seguirá la secuencia fenomenológica de Colaizzi / van Manen. Los hallazgos se estructurarán mediante redes conceptuales categoriales e informes narrativos densos ilustrados con verbalizaciones textuales directas (*quotes*) de los usuarios, preservando estrictamente el anonimato bajo identificadores alfanuméricos de reserva (ejemplo: Informante 01, Mujer, 34 años – Inf. 01).

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Asignación de recursos humanos

- **Investigadora Principal:** Gresly Lucero Pariona Palomino (Estudiante de la E.P. de Enfermería – UNSCH).
- **Asesor del Proyecto:** Dr. Manglio Aguirre Andrade (Docente Titular de la Facultad de Ciencias de la Salud – UNSCH).
- **Personal de Apoyo (02):** Asistentes de apoyo logístico, transcripción fonética e interpretación bilingüe en quechua chanka.

5.2. Presupuesto

5.2.1. Pago de servicios de personal

Servicios	U.M.	Cantidad	C. Unit. (S/.)	Total (S/.)
Coasesor / Especialista temático	Mes	04	500.00	2,000.00
Personal de apoyo (02)	Mes	02	500.00	1,000.00
SUBTOTAL				3,000.00

Tabla 2: Presupuesto de servicios de personal.

5.2.2. Programación de otros servicios

Servicios	U.M.	Cantidad	C. Unit. (S/.)	Total (S/.)
Impresiones y fotocopias de campo	Hojas	1000	0.20	200.00
Internet y conectividad para análisis	Horas	200	1.00	200.00
Procesamiento y codificación cualitativa (ATLAS.ti)	Unidad	01	500.00	500.00
Empastado de tesis / proyectos	Unidad	05	20.00	100.00
Traslado y movilidad local del equipo	Días	20	10.00	200.00
SUBTOTAL				1,200.00

Tabla 3: Presupuesto de programación de otros servicios.

5.2.3. Adquisición de materiales y otros

Materiales	U.M.	Cantidad	C. Unit. (S/.)	Total (S/.)
Material bibliográfico especializado	Unidad	02	50.00	100.00
Papel Bond A4 80 gr.	Millar	02	25.00	50.00
Memoria USB 32 GB para respaldo de audios	Unidad	02	40.00	80.00
Carpetas y fólderes para archivamiento	Unidad	10	1.00	10.00
Lapiceros y resaltadores	Unidad	10	2.00	20.00
Mascarillas KN95 y bioseguridad sanitaria	Caja	02	20.00	40.00
Alcohol en gel / líquido al 70 %	Litro	02	10.00	20.00
Imprevistos y contingencias operativas	Global	01	80.00	80.00
SUBTOTAL				400.00

Tabla 4: Presupuesto de materiales y suministros de bioseguridad.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 4,600.00 Soles.

5.3. Financiamiento

El presente proyecto de investigación será financiado de manera íntegra y exclusiva con recursos propios por la investigadora principal.

5.4. Cronograma de actividades

El dimensionamiento temporal del proyecto se sustenta en la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT), calculándose el tiempo estimado (t_e) mediante la formulación:

$$t_e = \frac{O + 4m + P}{6} \quad (1)$$

donde O representa el tiempo optimista, m el tiempo más probable y P el tiempo pesimista. Se establece una duración global de seis (06) meses, con inicio en agosto de 2026 y finalización en enero de 2027.

Actividades	Ago 2026	Set 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027
Presentación formal del proyecto	X					
Aprobación del proyecto por CIEI/Facultad		X				
Validación de instrumentos (Juicio de expertos)			X			
Revisión continua del marco teórico			X	X		
Coordinaciones con el establecimiento C.S. Belén				X		
Recolección de datos (Entrevistas en profundidad)				X	X	
Transcripción verbatim y procesamiento de datos					X	
Análisis cualitativo e interpretación categorial					X	
Elaboración y presentación del informe final						X
Sustentación de la tesis de licenciatura						X

Tabla 5: Cronograma de actividades del proyecto de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Hernández-Sampieri R, Mendoza CP. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill; 2018.
- [2] Donabedian A. The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor: Health Administration Press; 2005.
- [3] Watson J. Nursing: The philosophy and science of caring. 2nd ed. Boulder: University Press of Colorado; 2008.
- [4] Quintana L, Hermida J. La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. Rev Psicolog Cienc Afines. 2019;16(2):73-80.
- [5] Montes-Sosa G, Castillo-Sanguino N. El método fenomenológico en la investigación educativa. Diálogos sobre educ. 2024;15(29):1-15.
- [6] Cotán Fernández A. El método etnográfico como construcción de conocimiento. MÁRGENES. 2020;1(1):83-103.
- [7] Okuda Benavides M, Gómez-Restrepo C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Rev Colomb Psiquiatr. 2005;34(1):118-24.
- [8] Ministerio de Salud del Perú. Política Nacional de Calidad en Salud. Lima: MINSA; 2021.
- [9] Pineda EB, De Alvarado EL, De Canales FH. Metodología de la investigación: manual para el desarrollo de personal de salud. 2da ed. Washington D.C.: OPS/OMS; 1994.
- [10] Katayama Omura RJ. Introducción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, estrategias y técnicas. Lima: Fondo Editorial UIGV; 2014.
- [11] Ministerio de Salud del Perú. Líneas de Investigación en Salud al 2030: Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA. Lima: MINSA; 2025.
- [12] Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Prioridades Regionales de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030. Ayacucho: DIRESA; 2025.
- [13] Aguirre-Andrade M, Tenorio-Acosta I, Rivas-Díaz L, Valenzuela-Oré F, Sánchez-Simbrón M, Quino-Huamaní F. Promoción de salud y nivel de salubridad de las familias, en comunidades del Distrito de Cangallo, Ayacucho 2020. Rev Investig Salud. 2020;14(2):45-58.
- [14] Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Ferney-Voltaire: WMA; 2013.
- [15] Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Ginebra: CIOMS; 2016.

ANEXOS

Anexo 1: Guía de Entrevista a Profundidad Semiestructurada

Título: Percepción de la calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

Objetivo: Recoger la experiencia vivencial del usuario sobre la atención recibida en el Centro de Salud Belén.

I. Preguntas de Apertura y Clima de Confianza:

1. ¿Podría relatarme qué le motivó a acudir el día de hoy al Centro de Salud Belén?
2. ¿Con qué frecuencia asiste a este establecimiento y qué servicios o áreas suele visitar habitualmente?

II. Preguntas por Categorías Temáticas:

■ Categoría 1: Trato humano y empatía

3. ¿Cómo fue la forma y el trato que recibió por parte del personal de enfermería, admisión y consultorio médico?
4. ¿Sintió que el personal demostró amabilidad, calidez, paciencia y respeto hacia sus inquietudes, o percibió frialdad y apuro? ¿Le hablaron en quechua cuando fue necesario?

■ Categoría 2: Oportunidad y tiempos de atención

5. ¿A qué hora tuvo que llegar al centro de salud para conseguir su turno o cupo de atención, y cómo vivió esa espera en las filas de la madrugada?
6. ¿Qué opina sobre el tiempo total transcurrido desde que llegó al establecimiento hasta que ingresó a consulta y recibió sus medicamentos en farmacia?

■ Categoría 3: Condiciones físicas e infraestructura

7. ¿Cómo considera las condiciones de limpieza, comodidad de las bancas de espera, ventilación y la privacidad del ambiente donde recibió su atención?

■ Categoría 4: Información y claridad comunicativa

8. ¿Le explicaron con claridad y sencillez los diagnósticos, procedimientos y medicamentos que debe tomar? ¿Sintió la suficiente confianza y libertad para realizar preguntas sobre su salud?

III. Pregunta de Cierre:

3. Si usted tuviera la oportunidad de cambiar o sugerir algo para mejorar la calidad y calidez de la atención en el Centro de Salud Belén, ¿qué recomendaciones o propuestas plantearía?

Anexo 2: Matriz de Consistencia Cualitativa

Título: PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026.

Problema	Objetivos	Preguntas Norteadoras	Categorías de Estudio	Metodología
General: ¿Cómo perciben los usuarios la calidad de atención brindada en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026?	General: Comprender la percepción y vivencia de los usuarios sobre la calidad de atención brindada en el Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.	1. ¿Cuáles son las emociones y vivencias del usuario respecto al trato recibido? 2. ¿Qué significados otorgan a los tiempos de espera y colas? 3. ¿Cómo describen el ambiente físico y la privacidad en su atención? 4. ¿Cómo valoran la claridad de la información recibida?	Categoría Central: Calidad de atención percibida. Subcategorías: • Trato humano y empatía. • Oportunidad y tiempos de atención. • Condiciones físicas e infraestructura. • Información y claridad comunicativa.	Tipo: Cualitativa interpretativa. Diseño: Fenomenológico-Hermenéutico. Población/Muestra: Usuarios del C.S. Belén. Muestreo intencional por saturación teórica (12-18 participantes). Técnicas: Entrevista a profundidad y observación. Instrumentos: Guía de entrevista y diario de campo.

Tabla 6: Matriz de consistencia cualitativa del proyecto.

Anexo 3: Formato de Validación por Juicio de Expertos

I. ASPECTOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): _____
- 1.2. Grado académico del experto: _____
- 1.3. Profesión del experto: _____
- 1.4. Institución donde labora: _____
- 1.5. Cargo que desempeña: _____

1.6. Denominación del instrumento: Guía de entrevista a profundidad semiestructurada.

1.7. Autor del instrumento: Gresly Lucero Pariona Palomino.

1.8. Título de la tesis: Percepción de la calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

II. CRITERIOS DE VALIDACIÓN:

Criterios	Indicadores de Evaluación	Sí	No	Observaciones
1. Claridad	Formulados con lenguaje apropiado que facilita la comprensión del usuario.	[]	[]	
2. Objetividad	Expresados en conductas o vivencias observables y comprensibles.	[]	[]	
3. Consistencia	Organización lógica interna y relación directa con las bases teóricas.	[]	[]	
4. Coherencia	Existe relación estricta de las preguntas con las subcategorías de estudio.	[]	[]	
5. Pertinencia	Las preguntas orientadoras responden a los objetivos trazados en la investigación.	[]	[]	
6. Suficiencia	La cantidad y profundidad de las preguntas es adecuada para lograr saturación.	[]	[]	

Tabla 7: Ficha técnica de validación por juicio de expertos.

Observaciones generales:

Ayacucho, ____ de ____ del 2026.

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO**Anexo 4: Modelo de Consentimiento Informado**

Yo, _____, identificado(a) con DNI N° _____, domiciliado(a) en _____, Distrito de Ayacucho, Región Ayacucho.

He tomado conocimiento del estudio de investigación científica titulado: **“PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026”**, ejecutado por la investigadora Gresly Lucero Pariona Palomino, bajo la asesoría del Dr. Manglio Aguirre Andrade de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

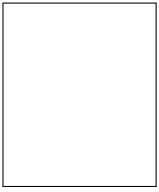
Declaro participar libremente en calidad de **Informante clave** y me comprometo a brindar información fidedigna sobre mis vivencias en el establecimiento. Se me ha informado con plena claridad que:

1. La entrevista será registrada en audio únicamente para fines de análisis cualitativo y transcripción académica.
2. Mi identidad será rigurosamente protegida mediante el uso de códigos o seudónimos despersonalizados, garantizando anonimato y confidencialidad.
3. Mi participación es 100% voluntaria y puedo retirarme de la entrevista o del estudio en el momento que juzgue conveniente sin que ello afecte en modo alguno la calidad de mi atención presente o futura en el Centro de Salud Belén.

Para dar constancia y conformidad a lo manifestado, firmo e imprimo mi huella dactilar al pie del presente documento.

Lugar y fecha: Ayacucho, ____ de ____ de 2026.

FIRMA DEL PARTICIPANTE


HUELLA DACTILAR

Anexo 5: Modelo de Carta de Asesoría Formal

Ayacucho, _____de enero del 2026.

Dr. Alejandro Yarlequé Mujica

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Asunto: Carta de Aceptación y Asesoría Formal de Proyecto de Tesis

Sirva la presente para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle la asesoría formal del Proyecto de Tesis con enfoque cualitativo titulado: **“PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026”**, perteneciente a la estudiante **Gresly Lucero Pariona Palomino**, egresada de la Escuela Profesional de Enfermería.

En tal sentido, dicha asesoría académica y metodológica comprenderá todas las etapas de formulación, dictamen ético, trabajo de campo, procesamiento y sustentación del trabajo de investigación, conducente a la obtención del Título Profesional de Licenciada en Enfermería.

Atentamente,

Dr. Manglio Aguirre Andrade

Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud – UNSCH

ORCID: 0000-0001-8234-567X | DNI N°: _____